

Médico-social, médico-légal et psychiatrie

Adolescents	3
Bases de l'approche de l'adolescent	3
Qu'est-ce que l'adolescence ?	3
Phases de développement de l'adolescent	3
Variations de la puberté et impact sur la santé	4
Les grandes pathologies de cette période de la vie	5
Adolescents et maladie chronique	6
Maladie chronique : définition et répercussions psychosociales	6
Adhérence au traitement	7
Transition de la pédiatrie aux soins des adultes	9
Contexte et définitions	9
Quels avantages à la transition ?	9
Recommandations et barrières à surmonter	9
Troubles des conduites alimentaires à l'adolescence	11
Définition et contexte	11
Épidémiologie et critères diagnostiques	11
<i>Anorexie</i>	12
<i>Boulimie</i>	12
<i>Troubles atypiques</i>	12
Complications somatiques	13
Traitements	13
Médecine légale	14
Maltraitance	14
Définitions	14
CAN team	14

Epidémiologie	14
Clinique de la maltraitance	15
<i>Ecchymoses</i>	15
<i>Brûlures</i>	16
<i>Shaken baby syndrom</i>	17
Fractures non-accidentelles	17
Maltraitance sexuelle	18
Pédopsychiatrie	20
Diagnostic et traitement du TDAH	20
Définition et modèle étiologique	20
Classification et critères	21
Evolution : psychopathologie du développement	22
Entretien clinique	23
Traitement	24
Conclusions	25
Développement psycho-affectif	27
Introduction, généralités et contexte	27
Les étapes de la vie	27
Pédiatrie et systémique	30
Approche systémique en pédiatrie	30
Définitions et concepts	30
Trois dispositifs	31
Frontières, perméabilité et hiérarchie	32
Physiologie familiale	33

Adolescents

Bases de l'approche de l'adolescent

Qu'est-ce que l'adolescence ?

L'adolescence est la transition entre l'enfance et l'âge adulte.

Elle commence à la puberté, et se termine... ? Lors de l'indépendance émotionnelle et financière des parents.

D'après l'OMS, l'adolescent est l'individu entre 10 et 19ans, et le jeune entre 15 et 24ans. Les jeunes gens (young people) sont les 10 à 24ans. Ce sont donc des limites arbitraires, mais utiles aux statistiques. En Suisse, 20% de la population est dans cette tranche d'âge.

L'adolescence est une période de grands changements physiques, psychiques et sociaux, et un temps d'**exploration**, avec de nombreuses **transitions** : de l'enfance à la vie adulte, de l'école à l'emploi, de la dépendance à l'autonomie, de la pédiatrie aux soins adultes et du traitement contrôlé au contrôle du traitement.

Phases de développement de l'adolescent

On peut distinguer une division en 3 phases de l'adolescence :

1. Adolescence précoce (10-14ans environ) :

- Changements biologiques
 - Filles: bourgeon du sein et développement de la pilosité pubienne, début de la poussée de croissance
 - Garçons: élargissement des testicules, début de la croissance des organes génitaux
- Changements psychologiques
 - Pensée concrète, mais début des concepts moraux; progression du développement de l'identité sexuelle (orientation sexuelle); possible intérêt homosexuel; réévaluation de l'image corporelle
- Changements sociaux
 - Séparation affective des parents; début d'une forte identification avec les pairs, début des comportements exploratoires (tabagisme, violence)

2. Adolescence moyenne (15-16ans)

- Changements biologiques
 - Filles: puberté avancée/finale et fin de la poussée de croissance; ménarche, développement de la forme du corps de femme avec dépôt de graisse
 - Garçons: mi-puberté, spermarche et émissions nocturnes; voix change; début de la poussée de croissance
- Changements psychologiques
 - Pensée abstraite (se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre), de plus en plus les capacités verbales, identification du droit avec la morale; début de l'idéologie fervente (religieuse, politique)
- Changements sociaux
 - Séparation affective des parents; forte identification avec les pairs; augmentation des risques pour la santé (tabac, alcool, etc.); intérêt par les pairs hétérosexuels; début des plans professionnels

3. Adolescence tardive (17-21 ans)

- Changements biologiques
 - Garçons: fin de la puberté; augmentation continuée de la masse musculaire et des poils
- Changements psychologiques
 - Pensée complexe abstraite, identification de la différence entre le droit et la morale, augmentation du contrôle des impulsions, développement approfondi de l'identité personnelle, perfectionnement ou rejet de l'idéologie religieuse et politique
- Changements sociaux
 - Développement de l'autonomie sociale; relations intimes; développement de la capacité professionnelle et l'indépendance financière

Variations de la puberté et impact sur la santé

Déterminants socio-économiques sur la santé, facteurs de risque et de protection, comportements de santé (très liés aux politiques de santé du pays) => ont tous des effets sur la puberté, qui détermine la vie adulte de manière importante.

Effets de l'âge de la puberté sur la santé :

- Puberté précoce : chez les garçons, effet psychologiques positifs (estime de soi), tandis que pour les filles, plutôt effets négatifs. Pour les deux sexes, risques d'être traités (jugements plus sévères) et de participer à des activités destinés à plus vieux qu'eux (maturité physique ne signifie pas maturité intellectuelle => prise de risque).
- Puberté tardive : mauvaise estime de soi chez les garçons, aucun effet grave chez les filles. Traité par les adultes...

Influences sur les maladies :

- Plus de convulsions épileptiques autour de la ménarche et des règles, certains cancers sont plus prévalents si puberté précoce, asthme plus sévère si puberté précoce...
- TADAH : plus de prise de risques, de comportements anti-sociaux à la puberté.
- Les comportements anti-sociaux sont aussi plus fréquents chez les pubertaires précoces
- Santé mentale : plus de dépression et d'anxiété chez les filles (biais de non-diagnostic chez les garçons ?), plus de psychose chez les garçons.
- Apparition de douleurs musculaires ou osseuses, apparition de symptômes somatiques.
- Obésité : fait commencer la puberté plus tôt chez les filles, plus tard chez les garçons

Comportements à risques/exploratoires :

Les comportements à risques (ou exploratoires) sont fréquents à l'adolescence. Ce sont des comportements qui entraînent des conséquences potentiellement négatives, mais qui sont en quelque sorte compensés par des effets positifs perçus (acceptation du groupe, plaisir...). Les comportements exploratoires sont fréquents et peuvent mener à mortalité et morbidité, suicide, comportement agressif, troubles de santé mentale, grossesses précoces, et infections sexuellement transmissibles.

Exemples :

- Tabagisme, mésusage de l'alcool, usage de substances illégales, pratiques sexuelles à risque, violence, comportement anti-social, non-utilisation de la ceinture/du casque, jeux d'argent, etc.
- Mais aussi : sauter des repas, alimentation non-équilibrée, manque d'exercice, trop de temps d'écran, manque d'adhérence au traitement dans les maladies chroniques, etc.

Tous ces comportements à risque sont très corrélés entre eux. Globalement, un adolescent qui a un comportement à risque en a souvent plusieurs autres.

L'adolescence: une passerelle vers la promotion de la santé :

Bon nombre des comportements acquis au cours de l'adolescence (comme les relations entre les sexes, les comportements sexuels, la consommation de tabac, d'alcool et d'autres drogues, les habitudes alimentaires et la manière d'affronter les conflits et les risques) dureront **toute** une vie.

L'adolescence offre des opportunités pour prévenir l'apparition de comportements nuisibles à la santé et leurs répercussions futures.

Donner des conseils pour diminuer les comportements à risque, mais aussi féliciter pour leur absence.

Fréquentation des médecins : 75-80% des adolescents consultent une fois par année. Il faut donc profiter de ces occasions pour donner des conseils. Or, dans la moitié des consultations (études US), 50% des adolescents n'ont reçu aucun conseil.

HEADSS : si on n'a pas beaucoup de temps, il faut en tout cas investiguer au moins **Home** et **Education/Employment**. Une bonne anamnèse est la plus importante chez les adolescents.

Les grandes pathologies de cette période de la vie

La plupart des adolescents pensent que leur santé est bonne. Ils sont par contre très sensibles aux maladies de la société (pauvreté, manque d'étude, précarité, exploitation...).

Sur les 20 causes de mort dans les tranches d'âge 15-24ans, 17 sont évitables. La deuxième cause de décès en Europe est le suicide, et la troisième la violence.

Les pathologies principales sont :

- Symptômes somatiques (céphalées, douleur abdominale)
- Fatigue (sommeil nécessaire en moyenne : 10h/nuit!)
- Mésusage de substances (souvent avec changements soudains dans le parcours scolaire, dans les relations familiales)
- Santé sexuelle (grossesse, IST)
- Santé mentale (dépression, TCA: aussi chez les garçons!)
- Obésité
- Maladies chroniques

La plupart des maladies de l'âge adulte commencent à l'adolescence.

Adolescents et maladie chronique

Maladie chronique : définition et répercussions psychosociales

Définition : condition ou problème nécessitant des soins continus pendant une période d'années à décennies et limitant les activités quotidiennes. Concerne 10% des adolescents.

HEADS pour un ado avec une maladie chronique

- **Home** : les parents jouent un rôle essentiel, mais de manière inégale entre mères et pères. Les mères s'arrêtent plus souvent de travailler pour s'occuper de leur enfants. Les parents ne sont pour autant pas plus souvent divorcés.
- **Education** : Les ados avec maladies chroniques font moins souvent des études secondaires (finissent moins l'école, suivent moins d'études, sont moins employés, sont moins bien orientés, académiquement et économiquement).
- **Eating** : les troubles du comportement alimentaire et les préoccupations alimentaires sont plus fréquentes chez les ados avec maladie chronique.
- **Activities** : la probabilité de participer aux activités avec les pairs est limitée par la sévérité de la condition et du traitement nécessaire. Le manque d'amis influence sur la santé.
- **Drugs** : les usages d'alcool, tabac, cannabis et drogues illégales sont plus fréquents.
- **Sexuality** : on croit souvent que leur sexualité est absente, mais ce n'est pas le cas, au contraire, les filles ont plus souvent une sexualité active et un antécédent de grossesse.
- **Suicide/mental health** : les symptômes dépressifs sont fonction de l'impact sur les activités et encore plus, de l'impact sur la socialisation.
- **Security/violence** : Les actes violents et de délinquance sont plus fréquents parmi les malades chroniques.

Donc : il y a plus de similarités que de différences entre les jeunes avec maladie chronique et les autres, mais ces problèmes sont rarement discutés par leur médecin.

Tabac, alcool, drogues et sexualité sont rarement discutés, mais dans 54% des cas, les parents sont présents à la consultation.

Education thérapeutique : souvent perçue comme non-valorisée par le professionnel (téléphone, interruptions...) et abordée selon la sensibilité du professionnel et non du jeune.

=> Rôle du médecin

- Comportement envers le patient : ne pas les prendre pour des bébés.
- Se centrer sur la personne et non la maladie.
- Aller au-delà de la maladie et discuter du reste de la vie.

1 jeune sur 10 a une maladie chronique limitant ses activités quotidiennes.

Avoir une maladie chronique n'est pas un facteur protecteur.

Les adolescents avec maladie chronique ont besoin des mêmes messages de prévention que les autres adolescents.

Le rôle du médecin est de les traiter en fonction de leur âge et de leur permettre d'acquérir le maximum de leur potentiel.

Indépendamment de leur condition, ce sont des adolescents, et ils se comportent comme tels.

Adhérence au traitement

C'est un point clé dans le suivi des adolescents avec maladie chronique.

Définitions :

- Compliance : dans une approche paternaliste, "obéissance" du patient aux instructions médicales.
- Adhérence : engagement actif et volontaire dans un procédé mutuellement acceptable pour produire un résultat préventif et thérapeutique. Se souvenir que très peu de personnes ont une adhérence de 100%, et que l'adhérence n'est pas limitée au médicament.

Formes de non-adhérence :

- Ne pas réaliser la prescription
- Prendre une dose incorrecte
- Prendre des doses au mauvais moment
- Arrêt précoce du traitement
- Augmenter ou diminuer la fréquence de dose
- Attendre avant d'aller consulter
- Ne pas participer à la consultation (si le parent prend tout en charge)
- Ne pas suivre les instructions du médecin
- "drug holidays", typiquement avec la trithérapie
- "white-coat compliance" adapter l'adhérence avant les consultations pour que le contrôle soit bon

Les taux d'adhérence complète sont relativement bas : 19% pour le diabète, 42% pour l'asthme, 27% pour le HIV. L'adhérence satisfaisante est autour de 60%.

Les facteurs prédictifs pour une bonne adhérence sont :

- Attitude soutenant le soignant
- Attitude soutenant les parents
- Motivation
- Traitement n'interférant pas avec la vie sociale
- Absence de traitement menaçant le bien-être mental ou physique
- Fort sentiment de normalité
- Ressenti des résultats du traitement
- Énergie et volonté à s'occuper d'eux-mêmes (surprotection parentale fréquente)
- Bonne communication

Les facteurs de risque pour un manque d'adhérence :

- Non-adhérence au plan (ne pas être d'accord avec ce qu'on propose)
- Effets secondaires
- Vie stressante
- Priorités multiples et conflictuelles
- Difficultés à former de nouvelles routines
- Ne pas être convaincu de l'intérêt/efficacité du traitement

Barrières à l'adhérence au traitement :

- Oubli ou perte du médicament
- Trop occupé ou pas assez de temps
- **Trop** de traitements
- Gênant
- Volonté d'être normal

Le niveau d'adhérence diminue avec l'impact sur la qualité de vie de l'absence de traitement.

Stratégies d'amélioration

Par rapport à l'adolescent :

- Donner des informations en tenant compte de son stade de maturité
- Tenir en compte les facteurs psychologiques (déprimé? Autres problèmes?)
- Adapter le traitement au style de vie du patient
- Communiquer les informations de manière directe, faire confiance à l'adolescent
- Adapter les doses (phase de croissance rapide!)
- Utiliser les nouvelles technologies (?)
- Demander des idées au patient

Par rapport à l'environnement de l'adolescent :

- si nécessaire, suggérer l'aide d'une soeur/frère, meilleur-e ami-e

Communication et contexte :

- Garder le même soignant attribué à un patient
- Évaluer l'adhérence de manière non-menaçante, vérifier les effets IIres
- Simplifier au maximum la prescription, négocier.

Transition de la pédiatrie aux soins des adultes

Contexte et définitions

La plupart des enfants avec des maladies chroniques, grâce aux progrès de la médecine, survivent beaucoup plus longtemps, et nécessitent donc maintenant aussi un suivi en médecine adulte.

Cette transition est une parmi beaucoup d'autres transitions caractérisant l'adolescence .

Transition : c'est un processus d'une vie cherchant à remplir les besoins d'un enfant malade lorsqu'il passe de l'enfance à la vie adulte. Son but est de maximiser les fonctions et potentiels pour la vie, grâce à des soins de haute qualité, **en continuité** entre adolescence et adulte. Ce processus est centré autour du patient. .

Le **transfert** est quand l'information ou des personnes passent de la pédiatrie à la médecine. C'est uniquement une composante de la transition médicale.

La transition devrait commencer au début de l'adolescence et être divisée en trois parties :

1. Préparation, en soins pédiatriques
2. Transfert aux soins adultes
3. Engagement dans les services de soins adultes

Quels avantages à la transition ?

Meilleur suivi, plus grand nombre de consultations depuis les recommandations pour une transition bien faite. Améliore donc la continuité des soins.

La transition est un processus à facettes multiples, qui s'occupe des aspects et besoins psychosociaux, éducationnels et vocationnels des adolescents .

Son objectif global est donc d'aider ces jeunes à **entrer dans la vie adulte**.



Age & time	Provider	Parent/family	Young person
Early	Major responsibility	Provides care	Receives care
Increasing Age	Support to parent/family & child/youth	Manages	Participates
Increasing Age	Consultant	Supervisor	Manages
Adult	Resource	Consultant	Supervisor/CEO

Evolution du leadership : avec l'âge, le patient prend le leadership de sa santé, et le médecin ne devient plus qu'une personne ressource, à qui il s'adresse quand il en a le besoin.

Recommandations et barrières à surmonter

4 points principaux à discuter avec les jeunes :

1. Les futurs soignants
2. Les futurs besoins
3. Les changements dans l'assurance maladie
4. Encouragement à la responsabilisation

Il y a rarement un bon respect de ces directives.

Barrières individuelles et personnelles :

- Low level of awareness of the need for advance planning among youth and their families.
- Patients', families', and pediatricians' reluctance to loose their close, long standing relationship.
- Fear, anxiety, or ambivalence about the transition to the adult system (trouver le bon moment, pas en même temps qu'un changement de vie scolaire par exemple)
- Environmental or family stresses and competing priorities
- Severity of the youth's disability and his or her level of maturity and understanding.
- Distorted perception of potential patient outcomes.

Barrières liées au système :

- Manque de professionnels de santé chez les adultes qui se sentent à l'aise avec des jeunes. Pour la plupart des spécialistes, les patients habituels les plus jeunes ont entre 40 et 50ans. 70% des professionnels n'ont pas ou très peu d'expérience avec les adolescents.
- Différences des services : en pédiatrie, salles de consultations très familiales (souvent beaucoup de personnes présentes autour de l'enfant), multidisciplinarité, beaucoup de soutien psycho-social, bonne connaissance des maladies rares, listes d'attente plus courtes, moins de patients.
- Pas de soutien institutionnel pour les transitions.

Aucun de ces barrières n'est insurmontable.

La transition devrait être :

- **Globale** : développer l'autonomie des jeunes, gérer tous les problèmes de l'adolescence, développer un plan de vie et non un plan de maladie, inclure tous le monde (spécialiste, infirmier-e, enseignant-e...)
- **Flexible** : adapté à l'âge et au développement (avec des limites tout de même, on ne reste pas en pédiatrie à 35ans), adaptée aux besoins, éviter les périodes de crises et de stress.
- **Coordonnée** : avec le médecin de premier recours, avec le spécialiste adulte, avec **tous** les professionnels impliqués, par le professionnel qui est en charge.

Éléments clés :

- Bonne préparation, bonne planification
- Implication de la famille
- Contact avec la médecine adulte
- Choisir le bon moment
- Travailler de manière coordonnée
- Impliquer le MPR
- Prendre en compte l'opinion de l'adolescent
- Avoir un **protocole** (checklist des étapes, qui fait quoi quand, qui s'assure que le protocole est suivi)

La transition doit être planifiée, efficace, et surtout, attendue par le patient.

Différentes méthodes : clinique de transition (difficile, rajoute une étape), **coordinateur** (souvent un-e infirmier-e), méthode mixte, éducateur.

Troubles des conduites alimentaires à l'adolescence

Définition et contexte

L'anorexie est un des troubles mentaux dont on **meurt**.

Les troubles sont : Anorexie typique, boulimie typique, TCA **atypiques** (les plus fréquents et les moins connus) et obésité. Les passages d'un des troubles à l'autre sont fréquents.

Caractéristiques communes

- Envahissement massif de la pensée par des préoccupations centrées sur la nourriture
- Perturbations de l'image corporelle
- Souffrance psychique
- Isolement social
- Comportement alimentaire « perturbé » (différents en situation d'anorexie ou de boulimie)

La porte d'entrée pour les soins est fréquemment somatique (maux de ventre, troubles du sommeil...). Le pronostic est le meilleur si le diagnostic est précoce.

Ce sont des troubles du même spectre que les addictions, et plus on les prend en charge tôt, meilleur est le pronostic.

C'est majoritairement à l'adolescence que les troubles débutent (mais aussi possibles à d'autres âges de la vie), et ils deviennent fréquemment chroniques.

Pourquoi plus souvent à l'adolescence :

- Remaniements corporels et psychiques, puberté
- Corps au centre
- Insatisfaction du corps fréquente à l'adolescence
- Reviviscence conflits non-élaborés de la prime enfance (vulnérabilité)
- Période d'anarchie des rythmes, y compris de l'alimentation
- Place du corps, du narcissisme et question de la dépendance et de l'autonomie se retrouvent au coeur de la problématique des troubles alimentaires.

Contexte psycho-social : Époque obnubilée par elle-même et son image. Société prônant beauté, jeunesse, minceur et maîtrise du corps (sport, chirurgie esthétique, industrie cosmétique, etc...).

Attention, aucun élément seul ne peut causer un trouble alimentaire, il faut tout un contexte et une vulnérabilité.

Cercle vicieux du maintien des troubles alimentaires : faible estime de soi => préoccupation focalisée sur le poids et l'apparence physique => régimes sévères => crises de grignotages, compulsions alimentaires => faible estime de soi.

Épidémiologie et critères diagnostiques

Épidémiologie

Anorexie mentale : 0.1% de la population générale, 0.5-1% des 12-25ans.

Boulimie : 1-3% de la population générale, 3-6% des 12-25ans.

Troubles atypiques : 5-15% de la population générale, 4-20% des 12-25ans.

Anorexie

DSM-V :

- Refus de maintenir un poids corporel au-dessus d'un poids minimum pour l'âge et la taille (IMC < percentile 3)
- Peur intense de prendre du poids
- Perturbation de l'image corporelle

Le critère de l'aménorrhée était présent mais absent depuis le DSM V (garçons et pilule).

Deux types : restrictif ou purgatif (vomi ou laxatif).

Présentation clinique/psychologique

Alimentation: Attitudes particulières par rapport à la nourriture (restrictions, sélections, **intérêt** pour la nourriture, confection exagérée de repas ou de gâteaux,...).

Vie relationnelle

- Régression affective
- Isolement des pairs avec surinvestissement des relations familiales
- Refoulement et désinvestissement de la sexualité

Fonctionnement intellectuel

- Surinvestissement intellectuel
- Envahissement de la pensée par des préoccupations centrées sur la nourriture
- Perfectionnisme

Activité physique

- Défaut d'investissement du corps
- Activité physique exagérée / hyperactivité
- Méconnaissance de la fatigue et de la maigreur
- Usage exagéré de la balance (=> rôle de la balance dans la famille souvent important)

Le diagnostic repose sur l'anamnèse et l'examen clinique.

DD : état dépressif, hyperthyroïdie, maladie de Crohn ou autre MICI.

Le diagnostic est souvent très clair, mais il est difficile à poser en vertu du **déni**.

Boulimie

Survenue récurrente de crises de boulimie : Absorption en une période de temps limitée (<2h) d'une quantité importante de nourriture avec sentiment de perte de contrôle sur la nourriture pendant la crise.

Comportements compensatoires visant à prévenir la prise de poids (vomissements provoqués, laxatifs, diurétiques, jeûne, exercice physique excessif, ...).

Au min. 2x/semaine, pendant 3 mois.

Estime de soi influencée de manière excessive par le poids et les formes corporelles

Troubles atypiques

Trouble de l'alimentation ne répondant pas aux critères spécifiques de l'anorexie ou de la boulimie.

Tableaux cliniques forts similaires mais à une moindre fréquence et/ou intensité.

Complications somatiques

Elles sont nombreuses, sur le coeur, le cerveau, le système endocrinien, hématologique et les os.

Atteintes endocriniennes : Chute des hormones thyroïdiennes, sexuelles (et donc risque d'ostéoporose!) et de croissance; augmentation maximale du cortisol.

Os : à l'adolescence, la calcification de l'os augmente massivement. Une anorexie à cette période diminue donc le capital osseux à l'âge adulte, qui commence à diminuer à la ménopause.

Atteintes cérébrales : changements structuraux (atrophie) et fonctionnels, qui mettent 2-8ans à se résoudre (peut-être pas complètement) => Symptômes psy : distractibilité, dépression, anxiété, agitation, troubles du sommeil, obsessionnalité et compulsivité => entretien et aggravation de l'atteinte psychique.

Évaluation clinique

Paramètres vitaux à contrôler à chaque consultation, pour savoir s'il faut hospitaliser.

Poids, taille, IMC, T°(hypothermie).

Peau, phanères (xérose cutanée, ongles cassants, cheveux secs, lanugo).

Troubles circulatoires : bradycardie, hypotension, extrémités froides, acrocyanose, hypothermie.

Il existe des critères de % du BMI médian qui déterminent l'hospitalisation et la pose de sonde.

Traitements

2 axes principaux, toujours en parallèle :

1. Psychiatrique
2. Somatique (régulier, toutes les semaines)

En complément : approches corporelles, musicothérapie, yoga... de plus en plus d'études de preuve de ces approches complémentaires.

NB : Plus la prise en charge est **précoce** et bien conduite, meilleur est le pronostic.

Traitement somatique :

- Reprise de poids et retour des règles (ou reprise de la croissance chez les garçons)
- Contrôle régulier du K⁺ en cas de vomissement, +/- substitution
- Vitamine D et calcium (même si ne suffit pas à l'ossification correcte) pendant toute l'amenorrhée

Traitements psychologiques :

- Thérapies basées sur la **famille** : en impliquant les parents dans la prise en charge, et plus en les excluant comme on le faisait avant

Evolution de l'anorexie : 4.9 % de mortalité, 47 % de guérison, 32.4 % d'amélioration de la maladie, 19.7 % évolution chronique

Ne pas oublier les **garçons!** Parfois associé à une psychose.

Prévention :

- Promouvoir dès l'enfance une bonne estime de soi et des valeurs non reliées à l'apparence ni au poids.
- Renforcer la prise en compte des besoins de sécurité relationnelle et d'ouverture aux autres
- Déconseiller les régimes
- Tenir compte du contexte socio-culturel et FORMATION de tous les professionnels concernés

Médecine légale

Maltraitance

Définitions

“L’enfant maltraité est celui qui est victime de la part de ses parents - ou d’autres adultes ayant autorité sur lui - de violences physiques, de sévices psychologiques, de négligence (ou d’absence de soins), ou d’abus sexuels pouvant avoir des conséquences graves sur son développement physique ou psychomoteur.”

Types de maltraitance :

- Physique : *cave* enfants moins de 4ans, pas toujours détectable.
- Actes d’ordre sexuel : au sens large, aussi exposition à des images ou des paroles obscènes.
- Négligence, carence en soins : peut survenir avant la naissance, d’ordre physique ou affectif.
- Psychologique : humiliation répétée, exposition à une **violence conjugale** (majorité des cas!).

NB : aucun élément pris isolément n’a de caractère spécifique (diagnostique) en faveur d’une maltraitance.

Il n’y a pas de gradation, toute maltraitance aura des conséquences, surtout à long terme.

La maltraitance est définie par son caractère **répétitif** (une fessée n’est pas une maltraitance, une fessée par jour l’est).

CAN team

CAN : Child Abuse and Neglect. La CAN-team est une structure hospitalière, pluridisciplinaire, en relation avec des structures extra-hospitalières, composée de pédiatres, chirurgiens pédiatres, gynécologues de l’enfant et de l’adolescent, pédopsychiatres, assistants sociaux, infirmiers et sages-femmes conseillères.

Missions : détections, soins, prévention, enseignement et recherche.

Cadre légal :

Code pénal suisse (CPS, art. 358) : les membres du corps enseignant, les travailleurs sociaux, toute personne ayant la charge d’enfants « ont le devoir » de signaler les mauvais traitements envers les enfants ... sauf les médecins et les avocats qui « peuvent » aviser l’autorité tutélaire.

Loi sur la protection des mineurs Vaud : les membres du corps enseignant, les travailleurs sociaux, toute personne ayant la charge d’enfants y.c. les médecins et les avocats « **ont le devoir** » de signaler les mauvais traitements envers les enfants.

Epidémiologie

Estimation : 1 enfant sur 5 est victime de maltraitance.

NB les cas qu’on connaît ne sont pas tous les cas qui existent.

En Suisse, 5’000 enfants par an sont frappés avec des objets.

Étude Halpérin et al, BMJ, 1996 sur les abus sexuels :

- 33.8% des filles / 10.9% des garçons signalent avoir subi un AOS

- 20.4% des filles / 3.3% des garçons révèlent un contact physique
- 5.6% des filles / 1.1% des garçons avouent avoir subi une pénétration

Un tiers des adolescents ont subi **plus d'un** AOS, près de la moitié ont été commis avant l'âge de 12 ans. 90% des abuseurs sont des hommes. 66% des abuseurs sont connus de leurs victimes (beaucoup plus dans d'autres études).

Mais pourquoi la maltraitance ? Conjonction de facteurs de stress peuvent augmenter le stress parental et faire "passer la ligne rouge". Maltraitance subie => maltraitance donnée (transgénération).

Maltraitance dans le secteur néonatal : violence intrafamiliale, aussi pendant la grossesse, dépendances, psychopathologies, difficultés sociales majeures... Le handicap de l'enfant est aussi un facteur de risque, tout comme les situations socio-économiquement précaires.

Il est donc important de **prévenir** pendant la grossesse et à la maternité.

Clinique de la maltraitance

Anamnèse

Détecter les facteurs de risque (parents <20ans, consommation de substance, psychopathologie, enfant handicapé...)

Red flags :

- Le délai de consultation, p ex pour une fracture, est suspect (en Suisse, les parents consultent normalement très rapidement).
- Histoire absente, vague, changeante. Documenter les récits des parents, dès l'entrée!
- Antécédents de traumatismes de >3 accidents par année

Recommandations :

- respecter le silence de l'enfant
- privilégier le récit libre plutôt que de poser des questions
- ne pas s'enfermer dans la notion de secret par rapport à l'enfant
- user de charisme et mettre l'enfant en confiance
- ne pas chercher à "faire avouer"
- ne pas chercher à établir la preuve
- ne pas juger les parents
- ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre des parents
- demander conseil à des collègues ayant plus d'expérience

Status

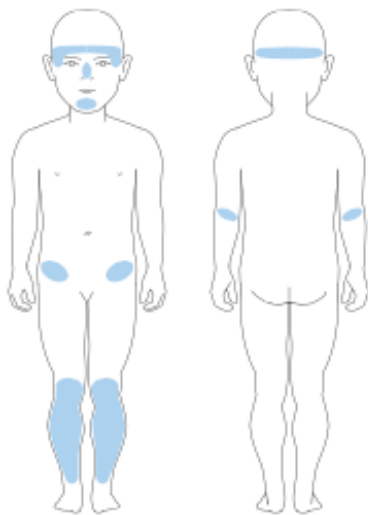
Déshabiller entièrement l'enfant! (à n'importe quel status chez l'enfant et l'ado). Régions cachées : Bouche, cuir chevelu, génital, oreilles...

Voir seul les adolescents!

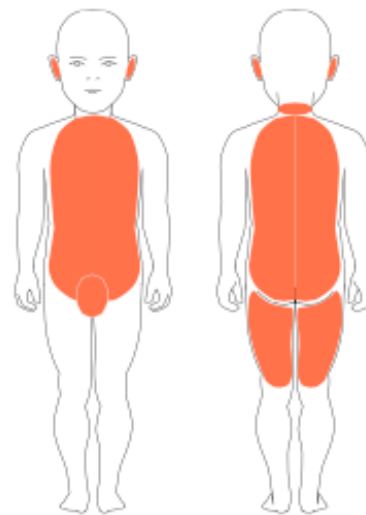
Ecchymoses

Les enfants ne marquent pas facilement (contrairement aux personnes âgées). Les lésions sont donc signes d'un impact important, surtout avant 9 mois (jamais de bleus à cet âge!).

Red flags : localisation, multiplicités, âges différents (coloration différentes), formes.



Illu. 3: Localisations typiques d'hématomes causés accidentellement



Illu. 4: Localisations typiques d'hématomes causés par des maltraitances

En cas d'ecchymoses chez les <1an : investiguer !

L'absence de mécanisme expliquant une lésion nécessite un **bilan radiologique** complet chez:

- les bébés < 12 mois s'il y a plusieurs ecchymoses
- les bébés < 6 mois avec une ou plusieurs ecchymose(s)

Ecchymose non expliquée chez bébé très prédictif de blessures et mortalité!

Marque de morsure : la taille permet d'exclure le petit frère/soeur et d'indiquer que c'est un adulte.

Lésions de l'oreille :

- Pavillon (tirer les oreilles): attention à la nécrose du cartilage
- Hématome retro-auriculaire
- Tympan: perforation par surpression (gifle)

Lésions de la bouche

- Dents: choc direct
- Gencives: lacération, frein de langue
- Langue: brûlures, morsures
- Palais: brûlures, lacérations

DD :

- Tache mongoloïde, bleutée, au niveau du sacrum.
- PTI (nombreux hématomes)

Brûlures

Localisation et âge de l'enfant sont des critères.

Spécifiques à la maltraitance :

1. Par immersion:

- a. Brûlure des fesses, du périnée et des membres inférieurs,
- b. Brûlure des membres en forme de gants ou de chaussette,
- c. Brûlure des membres symétrique,
- d. Brûlure avec des bords bien délimités.

2. Par contact: forme d'un objet

Shaken baby syndrom

Se voit avant l'âge de 2 ans. Accélérations / décélérations **brutales**.

Événements qui se répètent. Parfois "le seul moyen de calmer l'enfant" par semi-coma.

Diagnostics parfois ratés. *Cave* récurrence, et **séquelles** graves (épilepsie, handicap, troubles cognitifs).

Signes cliniques : Aspécifiques!

- Vomissements, irritabilité, convulsions
- Hypotonie, hypertonie, somnolence

A rechercher : Consultations précédentes (pour les mêmes symptômes), facteurs de risques, , hématomes, fractures,...

Triade :

symptômes neurologiques, hématomes sous-duraux, hémorragies rétiniennes (faire un fond d'oeil!).

Prendre le temps, hospitaliser, enquêter, réfléchir. Ne pas se précipiter.

Expliquer aux parents que la maltraitance entre dans le diagnostic différentiel, qu'on ne juge pas, qu'il s'agit de notre travail de s'assurer que le risque de récurrence n'est pas présent.

Investigations

RX squelette

Fond d'oeil (moins de 48h si bébé secoué)

IRM cérébrale et spinale (lésions des ligaments ou hématomes dans la moelle chez bébés secoués)

Laboratoire : crase, bilan métabolique (acide glutarique, enzymes hépatiques)

Fractures non-accidentelles

Les questions :

- Le mécanisme explique-t-il la fracture ?
- De quand date la fracture ?
- Est-ce une maltraitance, un accident, ...?
- Dois-je compléter les investigations ? Si oui, quel bilan radiologique ?

En cas de suspicion de maltraitance chez moins de 1an : bilan radiologique squelette entier et fond d'oeil.

Excuses et vraisemblabilité :

- Sur 530 chutes de la table à langer, 9 fractures (crâne et clavicule).
- Chutes des escaliers : tête et membre.

Mécanismes et types de fracture

Contrainte (torsion) : bras tenu, enfant se débat => fracture oblique ou spiroïde.

Choc direct ou écrasement => fracture transverse.

Cisaillement (un membre tenu, le reste du corps secoué) => fractures en coin, métaphysaires.

Compression : chute ou effet bras de levier => fracture comprimée.



Fractures et maltraitance :

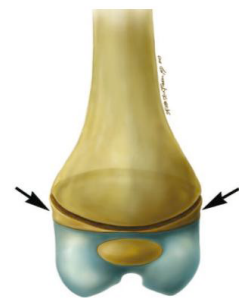
La fracture est la lésion la plus fréquente après les ecchymoses. Seul signe clinique dans 50% des cas. La plus fréquente c/o enfant décédé. Dans > 70% des cas, les parents/proches sont les agresseurs.

Fracture de n'importe quel type sur n'importe quel os: Membre 76%, Crâne 8%, Côtes 8% (la plus fréquente chez l'enfant décédé).

La maltraitance est responsable de 24-56% des fractures chez l'enfant <18 mois, et d'une fracture sur 3 chez l'enfant < 3 ans. Risque diminue avec l'âge, acquisition marche.

Fractures spécifiques :

- **Lésion métaphysaire classique (LMC)** : Fracture « en coin », anse de seau. Force de cisaillement, sur l'os spongieux primaire. Fémur, tibia ou humérus. Peu ou pas de cal se forme.
- Côte (nécessite une violence importante!). Localisée au niveau **postéro-médian**. Parfois peu visible, ou seulement 2 semaines plus tard. DD : après une réanimation (fait des fractures **antérieures**, 3-6^{ème} côte) ou traumatisme obstétrical.
- Omoplate
- Sternum
- Processus épineux



N'importe quelle fracture peut être la conséquence d'une maltraitance. La bonne documentation de la situation est une priorité.

Maltraitance sexuelle

Le souvenir ou la révélation d'un récit de maltraitance peut ressurgir à chaque **période de transition** (ménarche, accouchement, ménopause, divorce...). A tout âge, on peut donc être exposé à cette découverte chez un patient.

La révélation est souvent à la ménarche, lorsque l'abus devient pénétration, ou lors de l'information à l'école sur la sexualité.

La révélation, même des années après les faits, est une **urgence morale**. Nécessite une écoute et la mise en place d'un cadre de soin.

Abus sexuel : Tout geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique commis par un individu sans le consentement de la personne visée. Impliquant un abus de pouvoir, de vulnérabilité et/ou de

détresse, par utilisation de la force, de la surprise, de la contrainte, et/ou de la menace implicite ou explicite.

La fréquence est inversement proportionnée aux lésions. Les actes les plus fréquents sont donc ceux qui ne sont pas visibles. Par fréquence décroissante : actes auto-érotiques, contacts des organes génitaux de l'abuseur, attouchements, tentative de pénétration, pénétration.

Prise en charge et examen clinique :

1. Lésions (visage, cuir chevelu, dos...)?
2. Paramètres vitaux, examen de l'abdomen... Mettre en confiance!
3. Ne pas commencer par l'examen gynécologique. Explorer aussi l'ensemble de la santé : lésions, ecchymoses, morsures... **documenter**.
4. S'il s'agit d'une urgence somatique aussi :
 - a. Contraception d'urgence. Nouvelle : Ella-One (efficace 5j après le rapport). Ancienne Norlevo : 72h.
 - b. Prévention des IST : screening à T0 et 3 semaines plus tard, PEP (dans les 48h!). Vaccin hépatite B.
5. Examen gynécologique : L'hymen peut être annulaire ou semi-lunaire (variante anatomique, ne pas croire qu'il y a une lésion directement!). Se modifie à la puberté (croissance, épaissement). Lésion visible uniquement très précocement, mais faire tout de même un examen au moment de la révélation.

Ne jamais dire qu'il n'y a plus ou pas d'hymen. Seule possibilité : il n'est pas visible. => manoeuvres de traction ou écartement des grandes lèvres, rechercher des sécrétions ou des saignements.

Constat : écrire "on ne peut pas exclure un abus" quand il n'y a pas de lésions visibles, plutôt que "organes génitaux sp".

Entamer le soin sur le plan psychologique :

Il est surtout important de permettre d'en parler, et d'aider aussi toute la famille.

Indices-clés :

Signaux d'alerte pendant l'enfance : infections urinaires, douleurs abdominales, saignements génitaux => En cas de saignements chez une fille, il faut toujours faire un examen et une vaginoscopie, pour investiguer : traumatisme, corps étranger (aussi auto-placés, par forcément abus!), infection et abus.

A l'adolescence : tests HIV ou contraception d'urgence fréquentes, anorexie, auto-mutilation...

En cas de suspicion avérée :

Être transparent, expliquer "c'est de mon devoir de penser à infections urinaires, et autres, mais aussi de penser à l'abus", et demander aux parents quels sont leurs explications pour les symptômes. Souvent, grand soulagement pour la mère qui a aussi des soupçons.

Va mettre la vie de la famille en branle, nécessite donc du courage de la part des parents aussi.

Ne pas taire un tel soupçon, en parler à des collègues et le formuler.

Pédopsychiatrie

Diagnostic et traitement du TDAH

Définition et modèle étiologique

Entre 25 et 50% des adolescents ont un trouble remplissant des critères internationaux.

TDAH : trouble déficit de l'attention et hyperactivité. Le seul trouble psychiatrique chez l'enfant pour lequel on a un traitement médicamenteux, toujours au coeur du débat. Il fait partie des troubles **externalisés** comme le trouble oppositionnel avec provocation, le trouble bipolaire précoce et les troubles des conduites, qui sont tous des troubles aux conséquences sociales et sociétales.

Provoquent des difficultés familiales, du stress, et des dépressions (facteur de stress à long terme).

Poser le diagnostic de TDAH, et la pédopsychiatrie en général soulèvent un certain nombre de questions :

- Qu'est-ce que l'enfance? Quand commence-telle? Quand finit-elle? Quelle est la part de l'environnement et du relationnel dans la construction d'un enfant?
- Qu'est-ce qu'un développement « normal », physique, émotionnel, comportemental, social?
- Qu'est-ce qu'une éducation « normale »? A quel âge doit-on être autonome, attentif, discipliné?
- Qui doit définir le « normal » ou le pathologique?

Il est important en tant que médecin, particulièrement en psychiatrie, de ne pas porter de jugement. Avoir un regard neutre et bienveillant.

Le dépistage est difficile en pédopsychiatrie, car très vite, les “jeux sont faits”. Deux périodes critiques de remaniement biologique important : néonatalogie (dépression du post-partum), et adolescence (jusqu'à 25ans). Après, il n'y a plus que des remaniement psychologiques, mais plus biologiques. Le dépistage doit donc se faire le plus rapidement possible, déjà en crèche, en ratifiant en fonction du sexe (grandes différences au niveau du développement cérébral).

Les principaux symptômes sont : **Inattention**, **hyperactivité** et **impulsivité**. Définition : degré d'inattention et/ou d'hyperactivité et d'impulsivité très élevé pour un enfant de moins de sept ans.

Leurs caractéristiques :

- doivent être plus sévères que ce qui est observé chez d'autres enfants du même âge, ou du même niveau de développement
- doivent être présents dans **tous les champs d'activité** (par exemple famille, école)
- doivent créer de **sérieux problèmes** au quotidien
- **évoluent** avec l'âge et **persistent** souvent à vie.

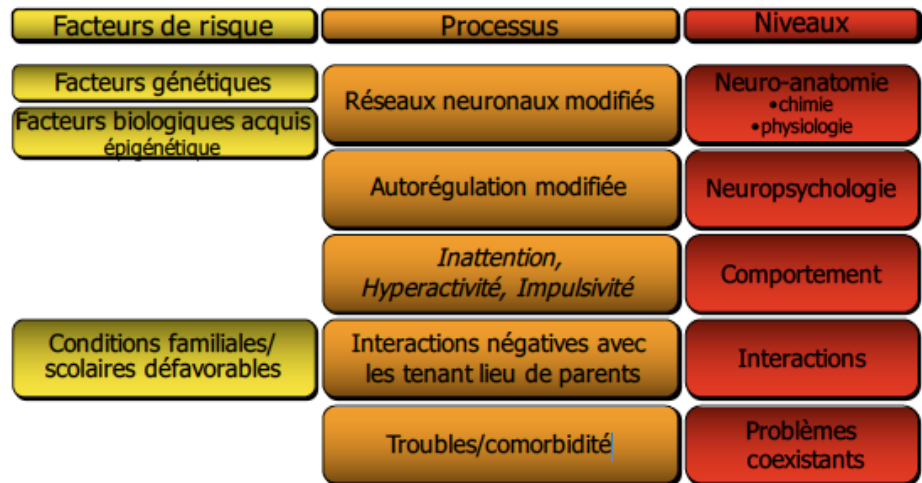
Mais ces patients peuvent avoir de nombreuses qualités : ils sont ouverts d'esprit, enthousiastes, dynamiques, drôles et souvent, extrêmement intelligents. Ils ont souvent peu d'estime d'eux-même, et doivent toujours ressortir de la consultation un peu plus sûrs.

A long terme, ces facteurs ont des effets **épigénétiques** (méthylations et déméthylations), qui sont transmissibles de génération en génération.

Dans les polymorphismes, **Met-Met** sont protecteurs, car ils permettent la résistance. **Met-Val** : moins bonne résistance. **Val-val** : les moins résistants (patients psy).

Modèle intégré :

Part du plus petit au plus grand, et décrit l'ensemble du système.

**Classification et critères**Classification DSM -V :

- Inattention + hyperactivité / impulsivité : TDAH, sous-type mixte. Le plus fréquent.
- Inattention seule : TDAH, sous-type à inattention prédominante. Adulte, jeunes filles.
- Hyperactivité/impulsivité : TDAH, sous-type à hyperactivité/impulsivité prédominantes.

CIM-10 :

Inattention + hyperactivité + impulsivité : trouble de l'activité et de l'attention.
Si trouble du conduite s'y ajoute : trouble de conduite hyperkinétique.

C'est donc un spectre de symptômes très large, aux limites floues. La classification est tout de même **catégorielle**.

Nouveautés du DSM-V :

Fait partie des troubles neurodéveloppementaux

- Critère A : Même critère pour inattention et hyperactivité/impulsivité. 4 propositions en plus pour impulsivité.
- Critère B : Présent avant 12 ans au lieu de 7 ans.
- Critère C : identique
- Critère D : identique
- Critère E : Suppression du trouble envahissant du développement dans le diagnostic différentiel.

Sous-types : ajout du sous-type inattentif restreint.

La prévalence est de 2-5%, suivant les critères.

Tableau clinique

Inattention :

1. A souvent de la peine à se concentrer en classe ou dans ses activités (p.ex. fautes d'inattention, ne prête pas attention aux détails)
2. N'arrive souvent pas à se concentrer longtemps ou est facilement distrait (p.ex. travail, jeux)
3. N'écoute que d'une oreille, semble souvent ne pas écouter quand on lui parle
4. Ne parvient souvent pas à suivre les consignes jusqu'au bout et à mener à terme ses devoirs scolaires, ou ses tâches domestiques, ou ses obligations professionnelles (cela n'est pas dû à un comportement d'opposition ni à une incapacité de comprendre les consignes)

5. A souvent des difficultés à organiser ses tâches ou ses activités (p.ex. ranger la chambre, devoirs scolaires, se mettre au travail)
6. Souvent, évite ou renonce à s'engager dans une activité demandant une attention soutenue (p.ex. tâches scolaires ou intellectuelles)
7. Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités (p.ex. jouets, cahiers de devoirs scolaires, crayons, livres ou outils)
8. Souvent, se laisse facilement distraire par des stimuli externes (p.ex. bruit, lumière, entourage)
9. A des oublis fréquents dans la vie quotidienne

Hyperactivité

1. Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège
2. Quitte souvent sa place dans la classe ou dans d'autres situations où il devrait être assis
3. Souvent, court ou grimpe partout quand il ne devrait pas, ou se met en danger (chez les adolescents et les adultes, ce symptôme peut se limiter à un sentiment subjectif d'impatience motrice)
4. A souvent de la peine à rester tranquille pendant les jeux ou les loisirs
5. Est souvent « sur la brèche » ou agit souvent comme s'il était "monté sur des ressorts" .

Impulsivité

1. Donne souvent des réponses sans attendre que la question soit complètement posée
2. A souvent du mal à attendre son tour (p.ex. jeux, file d'attente)
3. Interrompt souvent les autres ou impose sa présence (p.ex. s'impose dans les conversations ou dans les jeux)
4. Parle souvent trop

Le DSM-5 requiert la présence d'au moins 6/9 critères d'inattention et/ou d'hyperactivité/impulsivité pendant au moins les 6 derniers mois.

En comparaison, les critères ICD-10 (critères de recherche) sont moins rigoureux en ce qui concerne le nombre de symptômes requis, mais plus rigoureux en ce qui concerne l'atteinte/la persistance.

L'élaboration du diagnostic est finalement une question d'interprétation (par exemple, que signifie "souvent", ou "atteinte *significative*"?). Le diagnostic dépend donc de l'investigateur et de sa formation. Les critères sont les plus adéquats pour les **garçons âgés de 6-12 ans** avec une intelligence normale et moins adéquats pour les filles, les enfants préscolaires, les adolescents, les adultes et ceux atteints d'un retard mental.

Evolution : psychopathologie du développement

Symptômes principaux et troubles associés, conséquences :

1. Nourrisson et enfant de bas-âge (1-3ans) : tempérament pénible, trouble de la régulation émotionnelle, limitation de l'adaptation sociale => précurseur possible du TDAH.
2. Enfants préscolaires (3-6ans) : intensité et durée des jeux réduits, agitation motrice => troubles du développement, trouble oppositionnel avec provocation, problèmes d'adaptation sociale.
3. Enfants scolaires (6-12ans) : dissipation, agitation motrice, comportement impulsif et perturbateur. => troubles spécifiques de l'apprentissage, comportement **agressif**, estime de soi diminuée (voire état dépressif), redoublement de classes, mise à l'écart par les pairs, perturbation des relations familiales. Ce sont ces problèmes associés qu'il faut investiguer.
4. Adolescence (13-17ans) : difficultés de planification et d'organisation, inattention persistante, diminution de l'agitation motrice => comportements agressifs et antisociaux, troubles des

conduites et délinquances, abus d'alcool et de drogues, problèmes émotionnels, conduites à risque, accidents.

5. Adultes : symptômes résiduels => autres troubles mentaux, comportements anti-sociaux, délinquance, manque de réussite dans une carrière.

Il y a donc finalement des atteintes de tous les domaines de la vie.

Les symptômes principaux (inattention, hyperactivité et impulsivité), avec les troubles psychiatriques associés (troubles du comportement social, troubles anxieux ou de l'humeur) mènent à des atteintes fonctionnelles, à différents niveaux :

- Soi-même : Faible estime de soi, conduites à risque, accidents, et blessures, tabagisme/ abus de substances, délinquance.
- Ecole/Travail, Difficultés académiques/manque de rendement, Difficultés professionnelles
- A la maison : stress familial, difficultés éducatives.
- Vie sociale: vie sociale diminuée, difficultés relationnelles...

Entretien clinique

Il n'y a jamais des TDAH seuls, il y a souvent de nombreuses comorbidités (trouble de l'humeur, anxiété, trouble oppositionnel, tics...).

Pour commencer une prise en charge, l'adhérence au traitement et l'adhésion de l'entourage sont essentiels. La collaboration avec les parents est importante.

Les parents sont blessés, meurtris, et agressifs la plupart du temps, ce qu'il faut savoir gérer.

Anamnèse :

- Motifs de la consultation
- Histoire : Grossesse et accouchement (en particulier l'exposition à l'alcool et à la nicotine), développement psycho-social, maladies
- Psychopathologie/ troubles coexistants :
 - TDAH
 - Trouble oppositionnel avec provocation, trouble des conduites sociales
 - Dépression, trouble anxieux
 - Troubles spécifiques de l'apprentissage
 - Tics
 - Trouble du spectre autistique
 - Problèmes de sommeil
- Fonctionnement psychosocial et familial de l'enfant : Famille, école, enfants du même âge. Stress familial, pratiques éducatives, relations parents-enfants...
- Autour du patient : forces et compétences, vie quotidienne, perception de ses symptômes, autres problèmes, fonctionnement psychosocial...

Après le premier entretien, il faut surtout avoir réussi à avoir une **alliance** avec les parents.

NB : les symptômes peuvent ne pas être observables lors de divers examens. Il est donc important d'observer le comportement du patient dans des environnements familiaux (vidéos, observations de l'enseignant, du psychologue scolaire, etc peuvent être utiles).

Examen clinique :

- Taille, poids, périmètre crânien, tension artérielle, fréquence cardiaque
- Anomalies (p.ex. syndrome d'alcoolisme fœtal)
- Vue, ouïe
- Coordination motrice

- Quand un diagnostic différentiel est indiqué : status neuro, EEG, génétique, examens métaboliques, etc

Examens psychologiques :

- QI (presque toujours indiqué, pour voir si un retard mental est associé/présent seul)
- Capacités de lecture, écriture, calcul
- Fonctions neuropsychologiques : attention, apprentissage, parler et langue, perception, mémoire et capacité motrices
- Fonctions exécutives : inhibition, planification, mémoire, fluidité du langage, attention sélective et soutenue, régulation émotionnelle et motivationnelle...

Ces tests ne doivent être accomplis que s'ils sont indiqués. Il n'y a **pas** de test spécifique du TDAH.

Traitement

Domaines d'intervention :

- Auprès de l'enfant : sur ses différents symptômes
- Auprès de la famille : difficultés éducatives, charge familiale santé mentale des parents
- À l'école : difficulté d'apprentissage et échec scolaire, détérioration de la relation enseignant-élève
- Auprès des pairs : détérioration de la relation avec les autres enfants

Ils requièrent donc des interventions à plusieurs niveaux.

Efficacité des interventions :

- Psychopharmacothérapie : Effets à court terme démontrés, à long terme bien documentés pour une période de 5 ans. Critère d'efficacité : environnement (famille vs école, en combinaison avec TCC). Sévérité/symptômes associés n'ont apparemment pas d'influence majeure sur l'efficacité.
- Entraînement parental : Effets à court terme démontrés, effets à court et à long terme démontrés chez des enfants présentant des conduites d'opposition.
- Interventions sur le comportement à l'école : Effets à court terme démontrés
- Psychothérapie du patient : L'entraînement à l'autogestion et dans les compétences sociales peut aider, l'autoinstruction a moins de succès (problèmes d'application dans le quotidien), les thérapies qui ne sont pas axées sur le comportement n'ont pas été évaluées.

Médicaments

Posologie des stimulants d'action **brève** :

METHYLPHENIDATE (Les noms de marque dépendent du pays, notamment Ritaline)

- Normalement 10-50 mg/ jour. Dose quotidienne moyenne ~35 mg, dose quotidienne max 60 mg
- Normalement 2-3 doses/jour, 1 dose/jour suffit dans quelques cas

AMPHETAMINES (commercialisés récemment) :

- Normalement 1cp/jour
- En 2^{ème} intention

Stimulants d'action **prolongée** :

- Avantage d'une prise unique par jour, durée de l'effet 7–12 heures, libération en deux phases.
- Effets comparables à ceux de médicaments agissant à court terme avec plusieurs prises
- Début de l'efficacité clinique similaire aux stimulants d'action immédiate

Stimulants **noradrénergiques** : ATOMOXETINE

- Dosage : Spécifique selon le médicament
- Durée de l'effet : ~12 heures (et plus)

- Début de l'efficacité clinique : 2 à 3 semaines, voire 4 !
- Utile en cas de comorbidité dépressive. En 3^{ème} intention.

Effets Ires (la plupart sont transitoires):

Stimulants :	Noradrénergiques:
- Céphalées	- Perte d'appétit
- Douleurs épigastriques	- Étourdissement
- Perte d'appétit-perte de poids	- Dermatite
- Trouble du sommeil	- Dyspepsie
- Sécheresse buccale	- Anomalie d'ECF; somnolence

L'effet du méthylphénidate est le même que celui de la cocaïne, mais protège de la dépendance, car il a un effet moins instantané. Il peut donc même protéger de l'addiction un ado qui consomme de la cocaïne à côté. L'efficacité d'autres types de traitements (jeu, créative, psychodynamie, homéopathie) n'ont pas encore prouvé leur efficacité.

Algorithme de traitement :

Symptômes sévères, diffus et invalidants => médicaments.

Difficultés prédominants à l'école => intervention scolaire et auto-instruction.

Difficultés prédominants à la maison => entraînement parental, intervention familiale.

Symptômes persistants après le traitement du comportement => TCC et médicaments combinés.

Troubles associés : traitement spécifique (pharmaco ou comportemental).

Traitement des troubles associés :

- THADA + trouble oppositionnel/trouble des conduites : Combinez les stimulants et la TCC (par ex. programme d'entraînement parental)
- THADA + anxiété /dépression : Envisagez une association de TCC avec les stimulants et les IRS
- THADA + TIC : Envisagez une association de TCC avec des stimulants et des substances bloquant les récepteurs D2

Suivi : l'état général et les effets Ires doivent être surveillés par des entretiens clinique, l'examen physique, ECG et taux plasmatique des tricycliques si utilisés, ECG avant prescription de clonidine.

Conclusions

- Le TDAH est un trouble hétérogène aux degrés variables d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité.
- Le TDAH est souvent associé avec des troubles comme: Le trouble oppositionnel avec provocation, l'agressivité, les tics, les troubles développementaux de la coordination, l'anxiété, la dépression et la dyslexie.
- Le TDAH requiert une investigation globale de l'enfant par des spécialistes de divers disciplines - pédiatre et pédopsychiatre, psychologue pour enfant, neuropsychologue, pédagogue, éducateur - pour évaluer des profils du comportement, de la fonction cognitive, émotionnelle et sociale.
- La considération des aspects du diagnostic différentiel est essentielle.
- L'anamnèse doit également considérer les interactions familiales.
- L'anamnèse doit amener à des plans de traitements qui sont nécessairement à plusieurs modalités, comprenant le coaching parental premièrement, mais aussi la pharmacothérapie et les autres formes de thérapie appropriées (psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale, thérapie de famille).
- Des thérapies supplémentaires pour le traitement des problèmes d'apprentissage, d'autres troubles psychiatriques et des problèmes neuropsychologiques peuvent être nécessaires.

- Le bilan requiert de l'expérience, de la patience et du temps.

Développement psycho-affectif

Introduction, généralités et contexte

Constructions théoriques

Aux conceptions scientifiques s'ajoutent des conceptions mythologiques, symboliques et culturelles, car les enfants en sont aussi imprégnés.

Les 5 orientations théoriques en pédopsychiatrie sont : systémique, TCC (beaucoup d'études d'efficacité actuellement publiées), psychodynamique ("mise en sens", découle de la psychanalyse, "approche visant une compréhension raisonnée de la souffrance psychique"), neuroscientifiques (beaucoup de données, peu de réflexions) et théorie de l'attachement.

Comme en médecine somatique, il y a dans la psychiatrie des maladies qui proviennent "de l'intérieur", d'autres de l'environnement et enfin certaines sont liées à des accidents (traumatismes).

Spécificités de l'intervention pédopsychiatrique

Le seul outil médical est la rencontre, l'alliance. On ne peut pas retirer ce qu'on a dit, tout a un effet sur le patient. Buts : apporter des soins, gérer la crise, parfois contenir la symptomatologie (médicaments, hospitalisation), observer et évaluer une situation clinique afin de dégager à l'aide d'une démarche diagnostique une attitude thérapeutique, pour si possible remettre l'enfant ou l'adolescent dans une perspective développementale vers la subjectivation.

La régularité du traitement est importante, pour mener l'enfant à une confiance, qui permet un échange.

Particularités ++ (QCM) :

- Difficultés de définition du normal et du pathologique.
- Processus développemental : chaque situation est souple et dynamique.
- Hétérogénéité : chaque domaine n'est pas touché de la même manière (dysharmonie, immaturité)
- Le contexte est relationnel, donc interactif et sujet d'intersubjectivité.
- Prise en compte systématique de l'**environnement** : famille, foyer, prison... un enfant n'est jamais seul!

Les étapes de la vie

Avant la naissance : vie intra-utérine, influencée par le chemin parental (poids du transgénérationnel) autour de cette naissance (désir, non-désir, projections, intérêts...) et le contexte environnemental (contexte de guerre "produisant" des enfants filtrant difficilement les peurs p ex).

Nourrisson : c'est la période de mise en place de la **dépendance**. L'ocytocine, sécrétée pendant l'allaitement, permet l'attachement maternel. Chez l'animal, dès qu'il y a la capacité à vivre de manière autonome, il y a le processus de séparation - individuation. Le bébé humain est beaucoup plus dépendant que les autres mammifères, même après la période d'allaitement. Il y a une première période de **séparation - individuation** lors de l'apprentissage de la marche, et une seconde à l'adolescence, qui créent les deux une période d'angoisse de séparation.. Ce sont deux périodes de mortalité plus grande (accident et suicide). La **dépendance psycho-affective** se met donc en place, qui persiste et détermine toute la vie.

D'abord, toute-puissance infantile. Puis, la position **dépressive** (capacité à se déprimer à cause d'un évènement de frustration) commence quand il y a un lien de désir et de frustration/colère lors des premières opposition (ambivalence). C'est le début de la nécessité du doudou (objet **transitionnel**), et permet la mise en place d'une "bulle", espace psychique, permettant la présence d'une

ambivalence. L'absence de cette acquisition est une théorie pour la psychose (pas de "bulle" => échappatoire), ou pour les personnalités borderline (pas de capacité à gérer l'ambivalence). Une consultation dans cette phase doit se faire à travers l'analyse du lien parent-enfant, de cette intimité à deux, et elle est basée sur le récit parental.

Enfant préscolaire :

Découverte de l'autre, envie de pouvoir le modeler selon notre désir (= agressivité, dont il reste toujours une part en nous, qui se montre par une fascination pour les événements de mort, d'inceste, de violence). Totem et tabou : Début de mise en place de la **loi**, qui limite la toute-puissance de chacun. Pour accepter de suivre une loi, il faut avoir eu l'acquisition, vers 3ans, de la **théorie de l'esprit** (pour se rendre compte que les autres aussi ont un désir de toute-puissance).

Complexe d'**Oedipe** : vers 3-4ans, après la compréhension de l'individualité, compréhension de la différence entre les sexes, et désir de faire des bébés, avec amour pour son père/mère. Pour la fille, complication de confrontation avec la mère, car le père est aussi le tiers séparateur du duo avec la mère, et le rejet de la mère implique donc un conflit entre le socle du narcissisme primaire qu'est la mère et le rejet de ce socle => ambivalence permanente d'agression-réparation. La résolution de l'Oedipe chez la fille se fait, dans notre culture, par une tendance à aimer les chevaux (alliance entre féminin et masculin, queue, crinière...). La licorne, avec son pseudo-phallus sur la tête, est l'animal qui a le plus de fascination par les petites filles.

Pédopsychiatre : Analyse des grandes fonctions de l'**autonomisation**, leurs liens avec les parents et l'environnement proche ainsi que le pédopsychiatre (mise en place et gestion des fonctions instrumentales, sphinctériennes, motrice, du sommeil, des échanges et des vécus psychoaffectifs). Qualité de l'**angoisse de séparation**. Intimité corporelle - Récit étayé.

Enfance en latence, 6-12ans

C'est la phase des apprentissages de la socialisation. Pseudo-mise en veille des pulsions, développement du Moi et Surmoi. Surmoi : Autorité, dont l'autorité scolaire. Avant, faisait autorité par la force, et par le savoir. Avec la perte de cette autorité et l'incapacité des parents à mettre des limites aux enfants, on la remplace par la ritaline auprès de nombreux faux TDAH (il y en a aussi des vrais).

Vie fantasmatique riche, mise en place d'un espace psychique individuel, véritable bulle mystérieuse (continuation de l'objet transitionnel)

Mode de communication par le jeu et le **dessin** (la tête prend la majorité de la place chez la fille, avec des attributs féminins, le garçon dessine une grande fusée au centre), qui permet une réelle expression.

Évolution des dessins:

- Entre 3 et 4 ans : bonhomme têtard
- Entre 5 et 6 ans : apparition du tronc
- À 6 ans : bonhomme complet articulé
- Entre 7 et 12 ans : bonhomme dans l'espace

Dans la phase de latence :

Le soleil représente souvent le père, le nuage la mère (on peut y pleurer, s'y réfugier).

L'arc-en-ciel est l'alliance des deux.

Maison : toit = cerveau. Cheminée droite à partir de 7ans.

Chez des jumeaux : maison à deux portes.

Le dessin est un outil montrant la structure de l'enfant. Il permet d'évaluer son fonctionnement. On demande un dessin libre, un dessin de la famille, et un dessin de bonhomme.

Préadolescence

C'est le moment de l'apogée de la confiance en soi, de consolidation de l'espace imaginaire. Copains du même sexe, apogée du narcissisme, en prémisse du tremblement de terre de la puberté.

Peter Pan, est un conte raconté par les adultes pour instruire l'enfant. Peter Pan se confronte au capitaine Crochet (un adulte, qui a de la barbe, et un crochet, donc il lui manque quelque chose (castration)). Il a une grande épée, tandis que Peter Pan a une petite dague (= évolution sexuelle). Sa main a été mangée par le crocodile, qui vient quand il y a un tic-tac (= angoisse des adultes du temps qui passe). La fée clochette : toute-puissance infantile.

Développement du **narcissisme primaire** (donné par la confiance maternelle) et **secondaire** (en tant qu'être humain sexué).

L'adolescence

Puberté somatique et puberté psychosociale. C'est une phase **paradoxe**. Au niveau cérébral : Il y a à la fois un important élaguage des synapses, et à la fois la construction de nouvelles connexions. Demyélinisation et remyélinisation importante, et changements dans les systèmes de récompense et de prise de risque. La maturation se fait de l'arrière à l'avant, et commence donc par les régions liées à la **perception sensorielle** : sensibilités aux odeurs, ré-étalonnage auditif (volume de musique) et le grand développement des voies visuelles (et donc intérêt pour les jeux vidéos et grande sensibilité à tous les stimuli visuels), mais se termine par les régions frontales.

Trois grands passages dans le psychosocial :

- Un devoir : celui de s'**autonomiser** et d'accéder à l'âge adulte. Ravive le processus de séparation-individuation. Fortes angoisses, de la part de l'ensemble de la société, envers cette période de passage difficile => mise en place de rituels de passage (mort, substance (ici, c'est l'alcool), sexualité, valeur..).
- Un risque : celui de se tromper dans l'engagement vis-à-vis des **choix de vie**. Ravive la menace **identitaire**. Nécessite donc la confiance de la part des parents, et qu'ils aient des projets pour eux (car sinon, ils ne bougent pas, et peuvent finir par valoriser l'échec : la seule chose dont ils peuvent prévoir la venue, qui les maintient dans une certaine sécurité). Conduite **ordalique** : déresponsabilisation de ses actes, considérant qu'il y a une force supérieure qui détermine l'avenir (braver la mort, sans réelle tentative de suicide).
- Un deuil : celui du rêve de l'image d'adulte et de la sécurité de l'image d'enfant. Ravive le sentiment de **perte**. Après une enfance malheureuse, racket pour essayer d'attraper un bout d'enfance heureuse d'un autre enfant. Désidéalisation des figures parentales, et de tout ce qui était idéal avant => petites pertes (perte d'un objet) peuvent avoir des conséquences importantes car ravivent ce sentiment déstabilisant et important de la perte. Mise en place de l'**intimité**, et donc du mensonge : La chambre devient le lieu de la reconstruction narcissique, puis, plus il y a la confiance plus il y a une colonisation du reste de l'appartement (salle de bain, puis frigo...). => permet la mise en place de son identité, son affirmation. Problématique quand cette intimité/jardin secret est sur internet. Pour la jeune fille, passage par le regard de la rue pour savoir qu'elle devient femme, mais risque avec la tendance progressive d'exhibitionnisme sur internet. C'est pour assurer son identité, pas un appel à la sexualité.

Complément à but informatif sur les slides 20 à 48.

Pédiatrie et systémique

Approche systémique en pédiatrie

Définitions et concepts

Individu = qui ne peut pas être divisé.

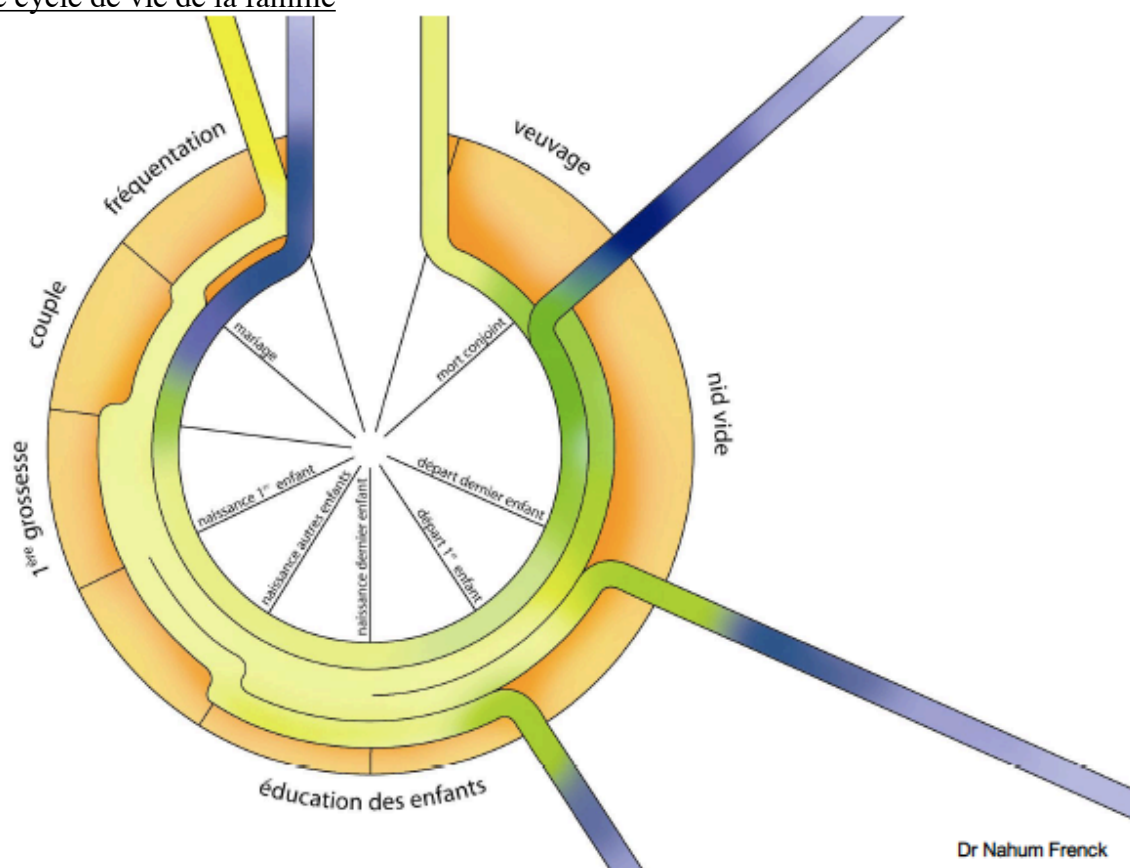
Holon : mot inventé par arthur Hoestler. Holos = tout, On = entité. Décrit des entités qui sont à la fois un tout, mais qui font partie d'un autre tout, comme un individu dans un système (famille, classe...).

Un arbre généalogique peut être vu comme un mobile, en équilibre. La perte, l'ajout ou la modification d'un élément implique un changement de son équilibre.

Chaque événement pour un holon modifie le système => **changement systémique**.

Dans un système, il y a deux dynamiques : une dynamique de maintien (le système se maintient, la famille reste une famille), et une dynamique de changement. La dynamique de maintien est maintenue par les parents, celle du changement par les enfants. Ces deux dynamiques sont constamment en échange et en confrontation, dans la **morphostase** et la **morphogenèse**.

Le cycle de vie de la famille



Dr Nahum Frenck

= La famille comme un tout au cours de son histoire.

Chaque ligne radiale est une **crise évolutive (turning point)**, qui signifie l'entrée d'un nouvel élément dans le mobile, qui signifie un changement structurel de l'équilibre. Le terme crise signifie ici rupture d'un équilibre en vue d'arriver à un nouvel équilibre. En Chinois, crise (Wei-Ji) signifie à la fois danger et opportunité.

Très souvent, les crises évolutives se superposent dans un système : p ex début de scolarisation en même temps de maladie d'un grand-parent. Les différentes crises aux différents niveaux interagissent aussi.

Ex : dépression post-partum après naissance du 3^{ème} enfant, suite au décès du grand-père 2j après la naissance. Femme confrontée à la fois à la mort de son père et la naissance de son fils, deux crises évolutives en même temps. A permis à la mère de dire à son bébé qu'elle est triste pour son père, mais heureuse de sa naissance. Est allée aux funérailles avec toute la famille y compris le bébé. A bien évolué, en évitant l'hospitalisation pour dépression post-partum.

Trois dispositifs

1. Hélicoptère :

Prendre de la distance, voir le tout depuis le haut, et se poser où on veut.

Vision **globale** de l'interaction présente. Perspective large de la situation.

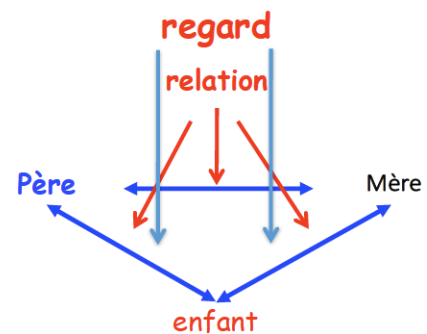
2. Zoom :

Une fois la vision globale aperçue, s'approcher d'un des holons. Etre avec le patient et non sur le patient. Complicité.

3. Macroscopie

Regard neuf sur la nature, la société et l'homme. Le macroscopie filtre les détails, amplifie ce qui relie, fait ressortir ce qui rapproche. "Il ne sert pas à voir plus gros ou plus loin. Mais, à observer ce qui est à la fois trop grand et trop complexe pour nos yeux...". Dans son champ de vision, les organisations, les événements, les évolutions s'éclairent d'une lumière toute différente.

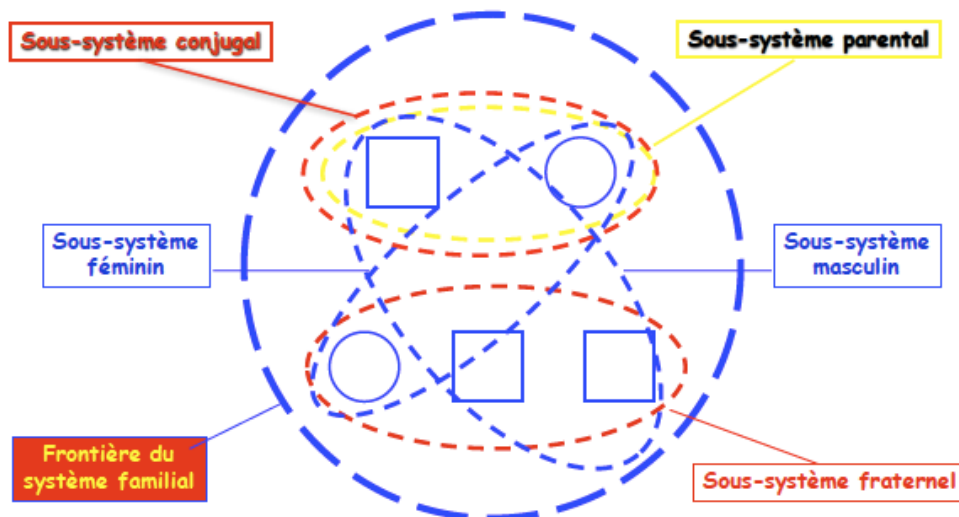
Il s'agit de passer du couloir au carrefour. S'élever pour mieux voir, se situer pour mieux percevoir... relier pour mieux comprendre.



Frontières :

Dans la perspective systémique on part du principe que la famille fonctionne comme un organisme vivant. Comme l'organisme vivant, la famille a une membrane semi-perméable qui s'appelle la **frontière familiale**. Cette frontière lui sert de ligne démarcation avec les autres systèmes, comme le système scolaire, le système médical, etc.

Mais dans une famille, il y a plusieurs frontières. Une frontière = les **règles** qui définissent **qui** participe dans le système ou sous-système et **comment** il participe.



C'est souvent dans le sous-système conjugal qu'il y a le plus de problèmes.

Le couple,

conjugal et parental :

Le lien parental et le lien conjugal sont comme **deux** câbles électriques passant dans une seule gaine. Couper l'un est difficilement dissocié de couper l'autre.

Frontières, perméabilité et hiérarchie

Cohésion

Certaines familles ont des frontières étanches, d'autres des frontières perméables et d'autres des frontières extrêmement perméables.

1. Type **enchevêtré** : frontières perméables entre les individus. Fusionnels, uniformes. Famille = un bloc. Jamais d'activité ou de liens à deux. Parmi les asthmatiques, ce type de famille est plus prépondérant, comme si l'asthme était une manière de dire "de l'air!". Idem pour les eczémas.
2. Type **désengagé** : frontière familiale très perméable, peu de partage à l'intérieur de la famille.

Les familles ont des **règles**, tacites ou explicites, qui lui servent à organiser les frontières à travers les interactions entre les membres de la famille et avec le monde extérieur, et qui servent à **organiser les frontières**.

C'est dans l'**interaction** entre le pédiatre et la famille que celui-ci se rendra compte que son rôle n'est pas seulement de comprendre pour soigner...mais de **participer** à l'élaboration d'autres réalités qui vont permettre à la famille d'élargir le champ de son devenir.

Ex : "c'est impossible qu'il réussisse, il a toujours été nul". Le rôle du pédiatre est de dire "le miracle existe". => ouvrir une nouvelle réalité, défaire les étiquettes mises sur les enfants.

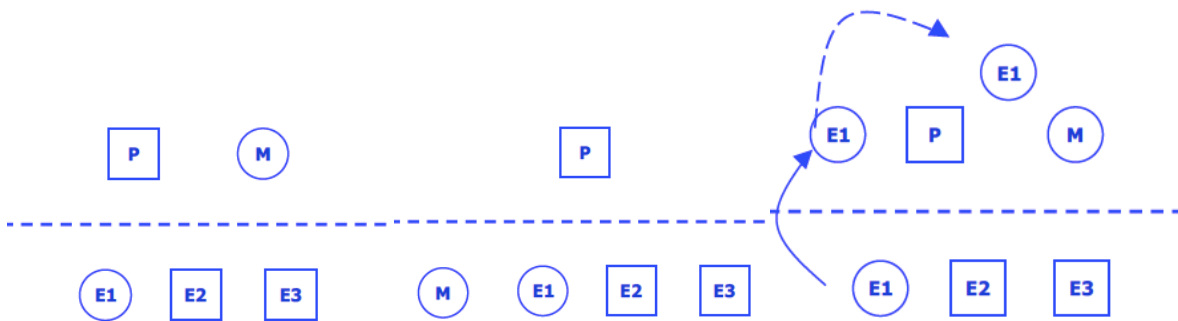
Dire de quelqu'un qu'il est quelque chose le formate à l'être.

Le systémicien utilise des verbes transitifs : non pas "il est voleur" mais "il est en train de commettre un vol" ; non pas "c'est un violeur" mais "c'est un monsieur qui a commis un viol". Donne l'espoir thérapeutique. Ratainer la partie mauvaise, garder les "tissus sains" entiers.

Notion de frontière et de hiérarchie

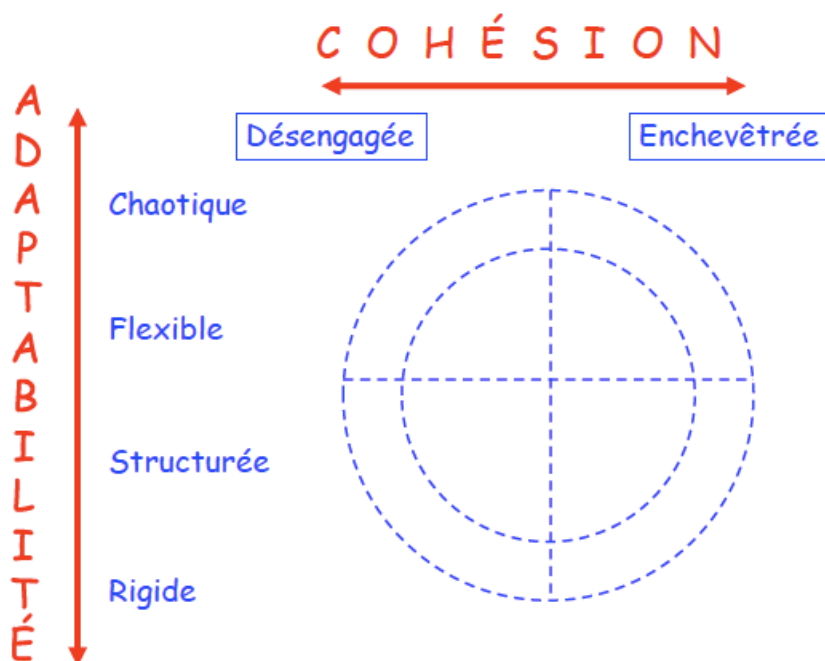
Les règles qui définissent les frontières de la famille se découvrent en observant le jeu. Lancer des sujets et thèmes, pour interagir avec les holons, et comprendre ainsi les règles qui régissent leur système. Ça signifie donc *entrer* dans le système et y prendre part.

Diagramme de la famille (Minuchin)



Montre la limite entre parent et enfant, et donc la hiérarchie familiale. Mais parfois un des parents est du côté des enfants (patriarche, père-ado...). Le fils apprend à devenir adulte avec l'exemple de son père. Enfant parentifié : l'enfant qui prend le dessus dans la hiérarchie (qui décide seul des décisions communes).

Cohésion et adaptabilité



Vignette: Papa avocat, maman enseignante, trois enfants en âge scolaire (10, 12 et 14ans).

Motif de consultation : n'obéissent pas. Récit : horaires stricts pour chaque activité, qui ne sont pas respectés par les enfants. = adaptabilité rigide, famille enchevêtrée.

Il n'existe pas de famille normale. Il y a des familles fonctionnelles et des familles dysfonctionnelles.

Physiologie familiale

Utilisation du génogramme et étude des frontières.

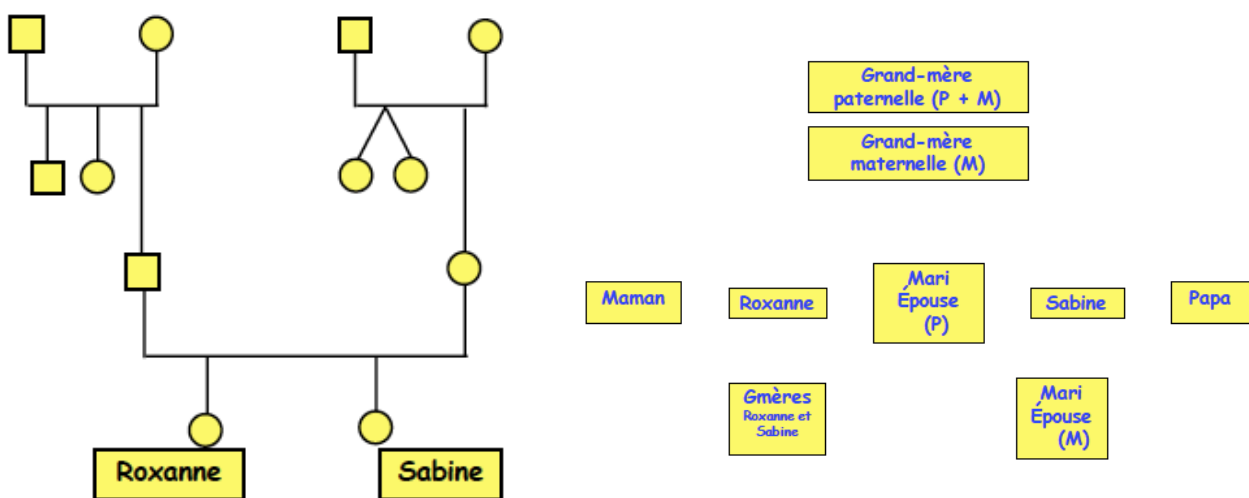
Hiérarchie structurelle et hiérarchie fonctionnelle sont différents. Ils doivent cependant être cohérents.

La majorité des problèmes viennent de la confusion entre demande et ordre. Les ordres donnent des points de repères clairs. Ex : ne pas demander si l'enfant veut manger, mais demander s'il préfère le yoghourt chocolat ou fraise après avoir clairement établi qu'il fallait manger.

Ex : Sabine, maux de ventre, toute cause organique exclue. Sabine dit que sa mère se plaint aussi de maux de ventre.

Le génogramme montre le schéma relationnel génétique, soit la hiérarchie **structurelle** de la famille, et sert de guide pendant l'exploration.

Pour mieux comprendre la structure **fonctionnelle**, demander aux membres de la famille où ils se situent.



Génogramme fonctionnel :

Exemple : Pour les deux parents, les grands-parents sont tout en-haut.

Pour le père, la famille est plate. Pour la mère, le père est en-bas.

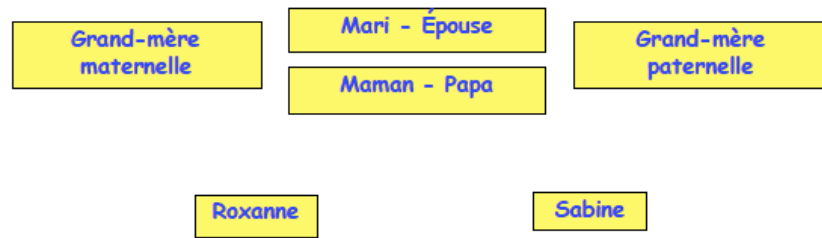
Pour les filles, les grands-mères sont en-bas et les parents les entourent.

Dans cette famille on peut remarquer une structure où les adultes sont encore trop "fils et fille de leurs mamans" pour pouvoir investir le rôle de parents. D'autre part quand ils le font, ils se font disqualifier par leur propres parents.

Dans la relation de couple conjugal les attentes sont différentes et au niveau du couple parental les parents n'arrivent pas à faire une alliance afin d'encadrer les enfants.

Hypothèse : La fonction du symptôme de Sabine serait de faire fonctionner les parents plus en tant que **parents** qu'en tant que **conjoint**s (même fonction pour la fugue). De cette façon le silence conjugal ou la discorde conjugale passerait à un deuxième plan.

Donc, le plan thérapeutique serait de travailler ensemble sur la structure relationnelle fonctionnelle de cette famille, afin d'arriver au schéma suivant, s'ils le désirent:



L'approche systémique est, pour le pédiatre, une certaine manière d'ordonner l'information reçue et d'aller chercher l'information nécessaire pour mieux comprendre le problème qui lui est soumis et avec les personnes concernés.

Il s'agit donc d'inclure la compréhension de la relation entre les différents membres du système familial dans l'anamnèse, dans l'examen du patient et dans la décision thérapeutique.

Une perspective systémique signifie avoir à faire à des parents et à leurs enfants en tant qu'individus en relation... analyser leurs relations et en observant leur communication, leurs interactions, leurs frontières ainsi que les perceptions que les uns ont des autres dans la dynamique du système familial.